

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	異位性皮膚炎 Atopic Dermatitis				
編號	A31000-Q03-W-H02	制定者	R10 陳倩芳	公布日期	112 年 03 月 07 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 1.2 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

讓護理人員了解異位性皮膚炎的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，使護理人員有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

異位性皮膚炎又稱為異位性濕疹，是一種反覆發作的過敏性皮膚疾病，常與遺傳有關，是嬰幼兒最常見的皮膚疾病之一，約占小兒人口的 3~5%，其中 60% 的病人會在 1 歲內發病，30% 的病人則在 1 到 5 歲之間發病。此等症狀還可能伴隨出現血清 E 型免疫球蛋白升高、過敏性鼻炎或是氣喘。

（二）症狀

慢性皮疹和皮膚搔癢是此病症最主要的表現，在嬰兒階段好發在臉部及身體的內側；兒童期的階段，皮疹則好發在身體屈側，例如：頸部、肘窩、膝窩、腋下等處。相較於兒童，成人以表皮增生、慢性病灶表現為主，較常出現頭、頸、手和腳的皮膚病灶，有些人則呈現非四肢屈側病灶的分布及非典型的型態變化，如：錢幣狀、水泡狀、類蕁麻疹及類脂漏性皮膚炎的型態。皮疹急性發作時，身上會出現丘疹及脫屑型紅斑，經長期搔抓後可能導致皮膚的增厚及苔癬樣的變化。因為搔癢難耐，病人常不自覺地抓到皮破血流，若此時細菌感染傷口，則可能會流膿液，出現焦糖色

主題名稱	異位性皮膚炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N10	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	2/7

的結痂，甚至導致蜂窩性組織炎。

(三) 診斷及常見檢驗檢查

1. 診斷仍以臨床表現為主，可採全球通行的 Hanifin and Rajka Criteria 診斷標準。

病人必須至少有三項以上主要特徵與三項以上次要特徵，才能診斷為異位性皮膚炎（見表 1）。

表 1.

主要特徵(Major features)	次要特徵(Minor features)
(1)皮膚搔癢 (2)典型的皮疹型態與分布-嬰幼兒或兒童出現在臉部和伸側皮膚-成人的屈側苔蘚化或紋線 (3)慢性反覆性的皮膚炎 (4)個人或家族的異位性體質病史（過敏性鼻炎、氣喘、異位性皮膚炎）	(1) 皮膚乾燥(xerosis) (2) 魚鱗癬、掌紋增加或毛孔角化 (3) 立即皮膚敏感測試陽性 (4) 血清中 E 型免疫球蛋白(IgE)升高 (5) 發病年齡較早 (6) 具有皮膚感染（尤其是金黃色葡萄球菌和單純皰疹）或細胞媒介免疫功能受損傾向 (7) 具有非特異性手、足皮膚炎的傾向 (8) 乳頭濕疹 (9) 唇炎(Cheilitis) (10) 復發性結膜炎 (11) Dennie-Morgan 眼眶下皺摺 (12) 圓錐角膜 (13) 前囊下白內障(Anterior subcapsular cataract) (14) 黑眼圈 (15) 臉部膚色白或臉部紅斑 (16) 白色糠疹 (17) 前頸部皺摺 (18) 出汗時搔癢 (19) 對羊毛或脂質溶劑無法耐受 (20) 毛囊周圍突出 (21) 對食物無法耐受 (22) 受環境與情緒因素影響而影響學習 (23) 白色皮膚劃紋症(White dermographism)或褪色反應延遲

2. 尚無明確的實驗室或病理學指標。血清中總 IgE 或抗原特異性 IgE 濃度升高，或是在皮膚測試中檢測到 IgE 媒介的致敏作用，是異位性皮膚炎最典型的特徵，

主題名稱	異位性皮膚炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N10	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	3/7

但並非所有的異位性皮膚炎都會出現此狀況，血中 IgE 不高也不能排除異位性皮膚炎。

（四）常見治療

異位性皮膚炎的治療方式可分為以下三線治療原則：

1. 異位性皮膚炎的第一線治療：潤滑劑、局部類固醇藥膏、抗組織胺藥物、日常生活衛生教育。
2. 異位性皮膚炎的第二線治療：局部塗抹鈣調磷酸酶(Calcineurin)抑制劑藥膏、口服或注射類固醇治療、紫外線光療（窄波段 UVB311 紫外線光療）、局部與全身性抗生素治療。
3. 異位性皮膚炎的第三線治療：全身性免疫調節藥物、生物製劑、更強效的局部類固醇藥膏、進階光線治療、其他替代療法、心理諮商與行為治療。

（五）護理問題

1. 皮膚狀態不完整/與皮膚乾燥、發紅、搔癢有關。
2. 易感染/與皮膚受損、使用類固醇有關。

（六）護理措施

1. 皮膚狀態不完整/與皮膚乾燥、發紅、搔癢有關。
 - (1)每日治療前，評估且紀錄個案皮膚癢的範圍、疹子的型態和皮膚完整性的程度。
 - (2)建議當皮膚發癢的時候，可以使用冷水清洗一下，或是用手輕拍搔癢的地方；或是使用冷毛巾冰敷的方式，在發癢的地方進行冰敷，每日至少 4 次以上，每次 15 分鐘，以減輕不舒服的感覺。
 - (3)用清水沖洗或以濕毛巾擦拭汗液，再換上乾爽的衣服，並盡量穿著柔軟、舒適、寬鬆、吸汗的棉質衣服。
 - (4)教導避免吃會導致過敏的食物，如牛奶、蛋、硬殼海鮮、堅果類、麥麩。寶寶出生後盡量餵食母乳六個月以上，或改為水解蛋白奶粉，副食品六個月後才添加，蛋白及全蛋製品，則兩歲以上再添加。

主題名稱	異位性皮膚炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N10	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	4/7

- (5)盡量避免接觸環境過敏原，枕套、被套跟床單，每週以 55℃ 熱水清洗或使用防塵寢具，室內不要養貓、狗、鳥類寵物，盡量避免玩絨毛玩具等。
- (6)協助家屬修剪個案的指甲，把指甲修剪成弧形並保持乾淨，避免抓癢而引起皮膚破損及感染。
- (7)情緒的起伏會讓異位性皮膚炎的病人不自覺的搔抓，壓力也會導致病情惡化，夏季天氣炎熱，容易造成心浮氣躁，產生皮膚癢疹，因此家屬必須格外留意病人情緒，為病人抒發緊張、激動的情緒。
- (8)建議可請家屬帶個案喜愛的物品、電動玩具或看電視等感官的刺激，來轉移對皮膚癢的注意力。
- (9)依醫囑給予類固醇靜脈注射、口服抗阻纖胺和外用止癢藥膏，藥膏勿塗太厚，20-30 分鐘吸收後，接著塗抹保濕劑。

2. 易感染/與皮膚受損、使用類固醇有關。

- (1)監測生命徵象注意有無發燒情形。
- (2)評估病人皮膚受損情形及有無感染徵象，如紅腫熱痛。
- (3)病人指甲剪短，並保持乾淨，避免抓癢造成皮膚破損，而導致續發性感染。
- (4)教導搔癢時，可用輕拍或冰敷方式，減輕其搔癢感。

(七) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

主題名稱	異位性皮膚炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N10	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	5/7

- (一) 朱家瑜、李志宏、吳南霖、卓雍哲、俞佑、施一新、張雲亭、黃麗珊、詹智傑、楊靜宜、賴柏如(2020)．異位性皮膚炎診療共識．2020 臺灣皮膚科醫學會異位性皮膚炎診療共識手冊（頁 1-48），社團法人台灣皮膚科醫學會。
- (二) 穆佩芬、李美銀、曾韻珊、孫瑞瓊、朱世明、吳怡萱...陳金彌(2019)．免疫系統異常患童的護理·於穆佩芬總校閱，兒科護理學（初版，212-215 頁），新文京開發。
- (三) Ascott,A.,Mulick,A.,Yu,A.M,etal.(2019).Atopicdermatitisandmajorcardiovascularoutcomes:Asystematicreviewandmeta-analysisofpopulation-basedstudies.JAllergyClinImmunol,143,1821-1829.doi:10.1016/j.jaci.2018.11.030

七、附件

(略)

主題名稱	異位性皮膚炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N10	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
112.03.07	1.0	新制定。	112 年 02 月 08 日護理長會議通過;112 年 03 月 07 日督導會議通過公布。
112.10.26	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.12.17	1.1	第三項第二目說明內容修訂。	113 年 10 月 15 日照護標準組會議通過；113 年 12 月 11 日護理長會議通過;113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。
115.01.06	1.2	1.第三項第三目表 1：次要特徵內容修訂。 2.第三項第四目第 2 點標點符號刪除。	114 年 10 月 02 日照護標準組會議通過；114 年 12 月 10 日護理長會議通過;115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。

主題名稱	異位性皮膚炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N10	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	7/7

修正日期	版本	修正說明	備註